

KC桌面——外资精译

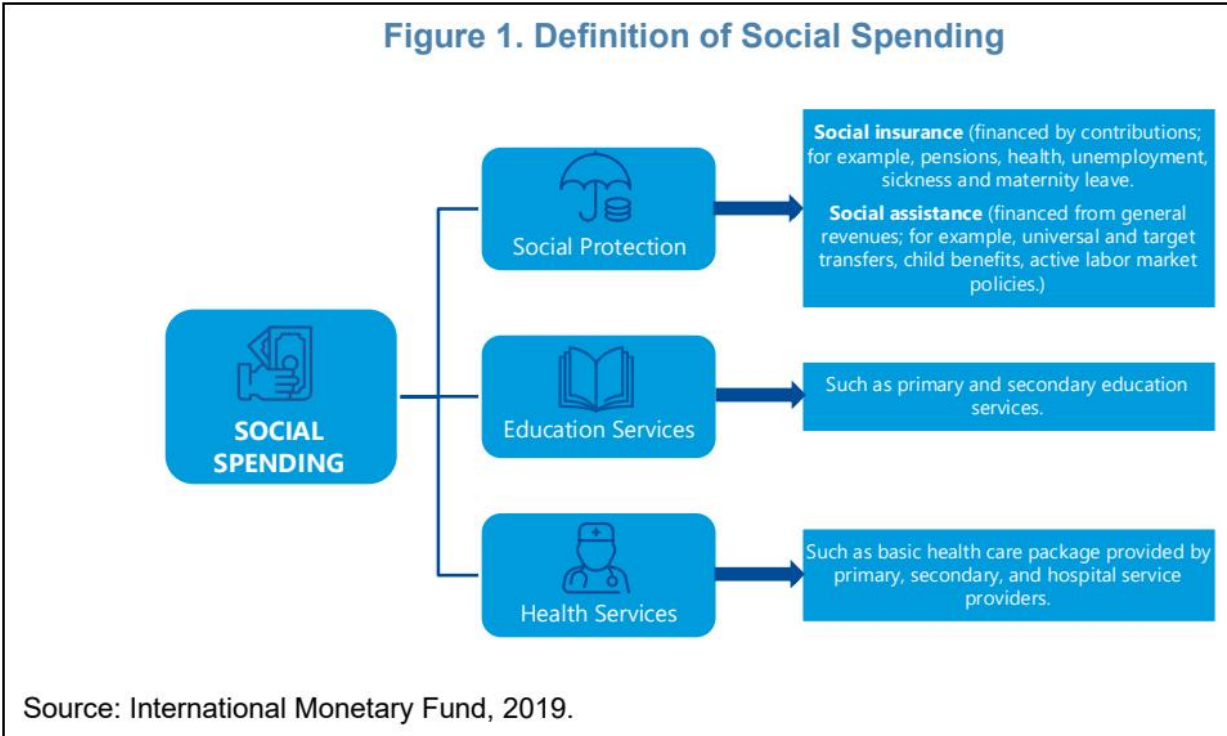
IMF：纳米比亚高等教育支出高于新兴市场，基础教育被挤占

纳米比亚是南部非洲收入中等但贫富差距极大的国家，2022年基尼系数高达0.63。这个国家在教育、医疗和社会保护上的公共支出占非利息总支出的56%，比例在同等发展水平国家中并不低。但国际货币产品组织（IMF）最新发布的国别报告指出，纳米比亚的社会支出效率存在明显短板——钱花了不少，但教育、健康和社会救助的实际效果并未同步提升。报告基于2026年5月完成的数据，从财政可持续性、支出充足性和支出效率三个维度展开分析。

教育支出偏高，但学习成果未达预期

纳米比亚公共教育支出占政府总支出约四分之一，高于同类收入水平国家的平均水平。但资金分配存在结构性倾斜：高等教育支出高于新兴市场地区均值，而小学和中学的生均支出却偏低。这直接反映在师生比上——中小学教师数量相对不足。尽管小学入学率表现不错，但中学入学率落后于同类国家，辍学率和留级率偏高。在数学能力方面，纳米比亚甚至低于撒哈拉以南非洲的平均水平。IMF使用随机前沿分析框架评估发现，过去二十年纳米比亚的教育支出效率改善有限，在南部非洲关税同盟国家中效率差距依然较大。

> KC评论：对政策制定者而言，关键问题不是“多花钱”，而是“钱往哪花”。纳米比亚的例子说明，教育支出向高等教育倾斜可能挤占了基础教育的资源，而后者恰恰是提升人力资本底部的关键。



图表 1

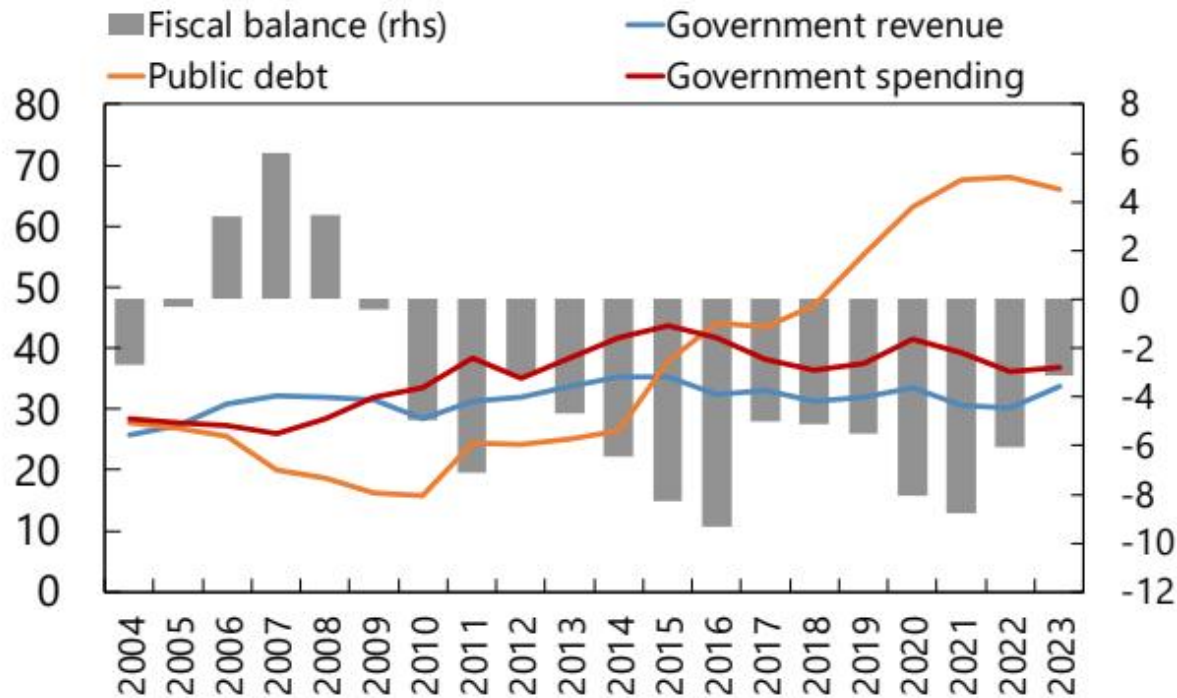
医疗支出充足，但体系分割影响效果

纳米比亚公共医疗支出约占GDP的5.5%，在同等收入国家中处于较高水平。IMF估算，纳米比亚要补齐与可持续发展目标相关的健康差距，所需额外资金仅相当于2030年GDP的1.4%，负担相对可控。但问题出在支出结构上：超过70%的卫生部预算流向医院和临床治疗，而预防和初级保健投入不足。更关键的是，纳米比亚的医疗融资体系高度分割——政府为公务员及其家属提供的医疗保险计划（PSEMAS）覆盖仅12%的人口，却消耗了约四分之一的公共医疗支出。这种安排导致不确定性池分散，公共资源难以向最需要的人群倾斜。结果，尽管支

出不低，纳米比亚的健康预期寿命（2021年为52.8岁）低于撒哈拉以南非洲和中等收入国家的平均水平。

> KC评论：PSEMAS的案例揭示了一个常见但容易被忽视的问题：公共支出中“隐形补贴”可能加剧不平等。公务员群体获得双重资源通道，而普通民众只能依赖资源紧张的公立系统，这种结构性问题不解决，单纯增加预算也难以改善整体健康指标。

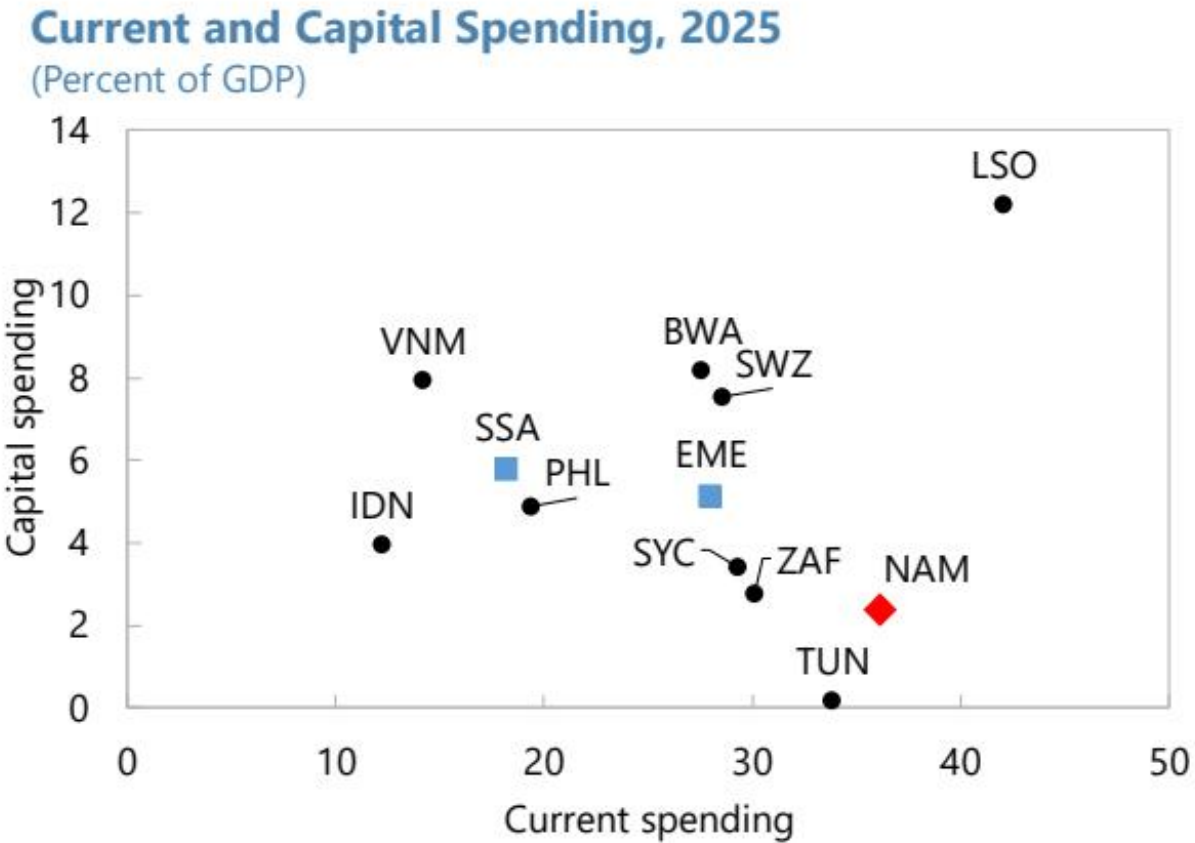
Fiscal Balance, 2004-2023
(Percent of GDP)



图表 2

社会救助覆盖面不足，精准度待提升

报告指出，纳米比亚的社会救助项目在覆盖面和目标精准度上仍有改进空间。以老年津贴为代表的大型项目，未能有效触达最脆弱的群体。与此同时，财政空间正在收窄——经常性支出占比过高，工资相关支出刚性大，资本性支出已降至GDP的3%左右。IMF强调，在收入增长有限、债务不确定性上升的背景下，改善支出分配效率是维持社会支出可持续性的关键路径，而非继续扩大支出规模。



图表 3